Palpación de hígado, bazo y colon

SEMIOLOGIA · Clase 25 · Chauffard, Mathieu, Schuster y la palpación deslizante

1 · EL FUNDAMENTO: ÓRGANOS QUE BAJAN AL INSPIRAR

Hígado y bazo bajan con la inspiración (F1 · F6)
el diafragma los empuja; por eso la mano espera bajo el reborde

por eso en lo normal

Normal (F6)
el hígado no rebasa el reborde costal; el bazo debe duplicar su volumen para asomar

para llegar a la profundidad

Preparar la pared
decúbito dorsal, piernas flexionadas, boca abierta; presión gradual, nunca brusca, lejos del dolor primero

los nombres sin teoría

Nombres sin respaldo en tu teoría
Merlo, Breuer, sirga y Güemes: preguntar en clase

2 · HÍGADO: CHAUFFARD, MATHIEU Y MONOMANUAL

Monomanual u ordinario (F1)
el tercer método: la misma idea con una sola mano

si rebasa el reborde, mide

o el método

Enganche (Mathieu) (F1 · F3)
mirando hacia los pies, falanges dobladas sobre el reborde derecho; inspiraciones repetidas

al enganchar obtiene el

Borde enganchado (F3)
se valoran su forma y su consistencia

si rebasa el reborde, mide

o la técnica de

Bimanual (Chauffard) (F1 · F2)
izquierda lumbar bajo la 12.ª costilla empuja hacia adelante; derecha bajo el reborde sostiene presión en la inspiración profunda

al inspirar siente que

El borde rueda (F2)
bajo los dedos con la inspiración; si no aparece, subir la mano en la espiración y repetir

si rebasa el reborde, mide

si va al hígado, usa

solo se palpa si ya es

3 · MEDIR Y DESCRIBIR EL HÍGADO

Hepatomegalia por traveses (F1)
pequeña hasta 2 · mediana hasta 4 · grande más de 4 o hasta el ombligo

si crece lento y es dura

si crece rápido, duele la

si es pétrea

Cápsula de Glisson
el parénquima no duele; duele la cápsula si se distiende rápido

Dura y de borde cortante
cirrosis (crecimiento lento, indolora)

Pétrea
cáncer

si es congestión, es

Dolorosa, lisa y blanda
congestión cardiaca o hepatitis

orienta

orienta

orienta

Tamaño, borde y consistencia orientan la causa de la hepatomegalia

4 · BAZO: BIMANUAL, MONOMANUAL Y SCHUSTER

si va al bazo, usa

Bimanual esplénica (F7)
izquierda costolumbar empuja hacia adelante; derecha (dedos en cuchara) bajo el reborde izquierdo avanza hacia arriba con cada inspiración

misma idea sin mano lumbar

si no concluye, pasa a

Monomanual (F6)
derecha plana bajo el reborde izquierdo, dedos hacia arriba; profundiza en la espiración y espera el choque del polo inferior

Posición de Schuster (F8)
decúbito lateral derecho, pierna izquierda flexionada 90°, brazo izquierdo tras la cabeza; el bazo cae hacia la mano

acerca el bazo al

también busca el

busca el

Polo inferior
choca con los dedos y se mueve con la respiración: así se distingue de otras masas del flanco

si se palpa, el bazo está

5 · BAZO PALPABLE: QUÉ SIGNIFICA

Bazo palpable (F6)
ya duplicó su volumen (2020; 2018: 2 a 3 veces); se mide en la mediocclavicular izquierda

exige buscar la causa

se llama

Un bazo palpable obliga a buscar la causa

Esplenomegalia
hipertensión portal, infecciones, leucemias y linfomas

si interfiere con la médula

Hiperesplenismo
anemia, leucopenia y trombocitopenia por interferencia con la médula

se confirma con

Se confirma con mielograma

si va al intestino, usa

6 · COLON: PALPACIÓN PROFUNDA Y DESLIZANTE

Obraztsov-Strazhesko (F11)
plegar la piel, entrar en la espiración y deslizar perpendicular al eje del segmento

en el mesogastrio palpa el

en la fosa ilíaca derecha, el

en la fosa ilíaca izquierda, el

Colon transverso (F9)
mesogastrio, de arriba abajo; cilindro transversal, móvil e indoloro

Ciego (F10)
fosa ilíaca derecha, línea espino-umbilical; cilindro blando que gorgotea

Sigmoides
fosa ilíaca izquierda; se valoran forma, consistencia, movilidad y dolor

orienta

orienta

orienta

Forma, consistencia, movilidad y dolor orientan la lesión del tubo

concepto · técnica · ejemplo · signo · mecanismo · diagnóstico · desenlace · causa · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología (09b, 09d) — teoría del docente; colon y Obraztsov: literatura